

Roteiro do Supervisor — o primeiro contato

Do primeiro "oi" no WhatsApp à conversa marcada · a cadeia essencial tem dois degraus (ADR-075): quero conversar → conversa marcada. **Qualificar É marcar a conversa** — não existe triagem antes de escutar.

Quem é você nesta conversa (ADR-100). Você não é recepção. Você é o **Supervisor do processo** dela: quem atende agora é quem vai estar lá no fim. Isso muda duas coisas neste roteiro — você **se apresenta como quem fica**, e não promete nada que outra pessoa teria de cumprir, porque a pessoa que cumpre é você.

Os princípios — leia antes de responder qualquer mensagem

- **A persuasão da Aliviar é a clareza.** Quem entende o que vai receber, marca. Quem é empurrado, some — ou pior: marca e se arrepende.
- **Cada mensagem conduz a UM próximo passo**, e ele é sempre o mesmo: a conversa marcada. Nunca duas perguntas na mesma mensagem, nunca um formulário.
- **Nunca prometemos:** médico específico, cura, resultado, prazo de melhora. Prometemos o que cumprimos: escuta de verdade e três opções com nome, explicadas, para *ela* decidir.
- **Nada de saúde por escrito, nem por você nem por ela (ADR-100).** Você recolhe o essencial para procurá-la e o que ela veio buscar em uma frase — **nunca história clínica**. Quem colhe a história é o Curador, na Consulta Inicial, porque é ele quem vai usá-la. Se ela mandar exame ou laudo agora: *"Guarda isso, que o Curador vai querer ver com calma."*
- **Sinal de urgência médica** (dor súbita intensa, sintoma agudo): interrompa o roteiro e oriente procurar atendimento de urgência agora. Acolhimento nunca atrasa socorro.

Mensagem 1 — a resposta ao primeiro contato

Responda rápido (o ideal: na hora; o aceitável: no mesmo período do dia). Curta, com nome, com pergunta única.

MODELO

"Oi, [nome]! Que bom que você escreveu. Eu sou [seu nome], da Aliviar — **vou te acompanhar daqui até o fim**. Antes de qualquer coisa, me conta em uma frase: o que está acontecendo com a sua saúde que te fez procurar a gente?"

Por quê: a primeira pergunta já é o Método — a história nas palavras dela. Não é triagem, é escuta começando. E o "vou te acompanhar até o fim" é a promessa da ADR-100 dita na primeira linha — quem lê isso não está falando com um atendimento, está falando com uma pessoa que tem nome.

Mensagem 2 — validar + explicar o que ela vai receber

Depois que ela contar, valide com uma frase que prove que você leu (repita UM detalhe do que ela disse), e só então explique:

MODELO

"Entendi, [nome] — [retome um detalhe: 'essa dor que já dura um ano e ninguém resolveu']. É exatamente para isso que a Aliviar existe. Funciona assim: a gente marca uma conversa (por telefone ou vídeo, sem compromisso), onde eu escuto a sua história inteira — o que você já tentou, o que não pode faltar num médico pra você. Com isso, a nossa curadoria compara os profissionais da nossa rede ponto a ponto com o SEU caso e te apresenta três opções, com nome, explicando por que

cada uma faz sentido pra você. Quem escolhe é você — a gente não indica um, te mostra os que combinam e o porque."

Por quê: é o produto inteiro em 5 linhas, sem promessa que não se cumpre. "Sem compromisso" derruba a barreira; "quem escolhe é você" é a nossa diferença — diga sempre.

Mensagem 3 — o fechamento: marcar a conversa

MODELO

"O próximo passo é só esse: a nossa conversa. Eu tenho [dia X às Yh] ou [dia Z às Wh] — qual fica melhor pra você?"

Por quê: duas opções concretas fecham mais que "quando você pode?" — decidir entre A e B é fácil; decidir no vazio é adiável. É a única técnica de fechamento que usamos, porque é honesta: as duas opções são reais.

As objeções — e a resposta honesta de cada uma

"Quanto custa?"

"A Aliviar custa **R\$ 500 por um ano**, que dá para dividir em **12 vezes de R\$ 41,67** — cobre a curadoria inteira, o relatório com os três caminhos e o acompanhamento durante o ano. **A consulta com o médico que você escolher é à parte**, paga direto com ele: a Aliviar não recebe nada dela, e é por isso que a gente pode ser honesta sobre quem apresentar. **E esta conversa aqui não custa nada** — você só decide depois de saber exatamente o que vai receber."

*Por quê: o número é **fixo** (ADR-101). Você não tem margem para desconto e não ganha por conversão — é isso que permite você continuar ao lado dela depois sem que a sua presença tenha interesse dentro. Se ela disser que não cabe, a resposta é **parcelamento**, nunca abatimento: preço que cede para quem insiste cobra mais caro de quem não insistiu.*

"Isso é uma consulta médica?"

"Não — e é importante você saber disso. A gente não diagnostica nem trata: a gente te escuta com profundidade e encontra, entre médicos verificados, os que mais combinam com o seu caso e com o seu jeito. A consulta médica vem depois, com o profissional que VOCÊ escolher."

"Me passa logo o nome de um médico bom?"

"Entendo a pressa — mas 'bom' depende de pra quem. O médico certo pra outra pessoa pode ser errado pra você: convênio, cidade, jeito de conduzir, o que você já viveu. É por isso que a gente escuta primeiro. Na conversa de [X minutos] eu entendo seu caso, e aí as opções que você recebe são SUAS, não uma lista genérica. Fica melhor [dia X] ou [dia Z]?"

Por quê: a objeção mais perigosa — ceder aqui destrói o Método. A resposta transforma a "demora" no argumento de valor.

"Vou pensar." / silêncio

"Claro, [nome] — sem pressa nenhuma. Só me diz uma coisa: ficou alguma dúvida que eu possa esclarecer agora? Às vezes é mais rápido perguntar do que pensar sozinha."

Se seguir o silêncio: UM lembrete gentil após 2–3 dias ("Oi, [nome] — seguimos por aqui quando você quiser. Sua história ficou comigo."). Depois, paz. Insistência é o oposto da nossa marca.

Depois do sim — confirmar e segurar a presença

CONFIRMAÇÃO (NA HORA)

"Fechado: [dia], às [hora], por [telefone/vídeo]. Reserva uns [X] minutos num lugar tranquilo — essa conversa é sobre você, e merece atenção. Até lá!"

LEMBRETE (VÉSPERA)

"Oi, [nome]! Amanhã às [hora] é a nossa conversa. Se quiser, deixa à mão o nome do que você já tomou/tentou — ajuda, mas não é obrigatório. Até amanhã!"

*Se ela faltar: "Oi, [nome], senti sua falta hoje! Imprevisto acontece — te ofereço [novo dia X] ou [dia Z], qual serve?"
Uma remarcação de coração aberto; na segunda falta, a porta fica aberta sem nova cobrança.*

O que NUNCA sai do seu teclado

- "O melhor médico da cidade" / "excelente profissional" — nós não ranqueamos; nós explicamos compatibilidade.
- "Vai resolver seu problema" / "tenho certeza que você melhora" — promessa de resultado é proibida.
- "Só hoje" / "últimas vagas" — escassez fabricada. Se a agenda está cheia de verdade, diga a verdade.
- Diagnóstico, palpite clínico, opinião sobre conduta de outro médico.
- Terceira mensagem de cobrança para quem silenciou.
- **Qualquer desconto.** O preço é fixo (ADR-101) e você não tem margem. Quem cede aqui ensina a insistir — e cobra mais caro de quem não insistiu.
- **Opinião sobre qual dos três caminhos.** Nem agora, nem depois. Você acompanha a decisão dela; no minuto em que você tem preferência, a promessa de independência cai (ADR-100).
- **Prometer que você estará na Consulta Inicial.** Quem pergunta é o Curador, na hora, e a resposta é dela (ADR-103). Você não combina isso por mensagem.

Aliviar Curadoria Médica · Roteiro do Supervisor v2 · 28/08/2026 · reescrito para as ADR-100 a 107 — a v1 descrevia uma recepção que entregava o caso e saía · companheiro do Guia da Primeira Rodada (docs/rede/) · a entrada e o número de parcelas ainda não estão definidos: não improvise parcelamento na conversa · rascunho operacional — revisão jurídica pendente junto com termos e privacidade.